

«Бронхіальна астма»

1. Завдання, що виконуються здобувачем освіти на станції:

- продемонструвати комунікативні навички (*привітатися з пацієнтом; назвати себе; запитати, як звертатися до нього; запропонувати зручно сісти; забезпечити під час бесіди ізоляцію від впливу різних подразників (сторонні розмови, телефонні дзвінки, тощо); сісти поруч за стіл*).
- спитати скарги та деталізувати їх;
- в'яснити анамнез захворювання та життя;
- продемонструвати практичну навичку “Аускультация легень”;
- виділити провідний синдром;
- надати рекомендації щодо профілактики та пропаганди здорового способу життя;
- продемонструвати невербальні компоненти ведення бесіди (тактовність, ввічливий тон, вираження емпатії тощо).

2. Клінічні кейси (сценарії, задачі), які відпрацьовуються на станції:

- Сценарій «Збір скарг та анамнезу, об’єктивне обстеження хворого з діагнозом бронхіальна астма»
 - Додаток 1. Характеристика перкуторного звуку. видається здобувачу освіти після проведення навички у паперовому вигляді)
- Над всією поверхнею легень визначається тимпанічний звук.

3. для студента – алгоритм роботи на станції:

Ви лікар терапевтичного відділення. До Вас звернулася жінка.

Алгоритм дій здобувача.

	Дії здобувача освіти	Текст стандартизованого пацієнта
1.ПРОДЕМОНСТРУВАТИ НАВИЧКИ КОМУНІКАЦІЇ.		
<i>Привітатися з пацієнтом</i>	Доброго дня.	Доброго дня.
<i>Представитися, позначити свою роль</i>	Я лікарка-терапевт, Раїса Іванівна. Я з Вами поспілкуюсь, огляну, проведу обстеження.	Добре
<i>Запитати пацієнтку, як до неї можна звертатися</i>	Як я можу до Вас звертатися?	Валентина Миколаївна
<i>Уточнити вік пацієнтки</i>	Скільки Вам років?	30 років
<i>Уточнити заняттєву активність</i>	Ви працюєте?	Я працюю продавчиною.
2.ІНШЕ (В Т.Ч. ЛЕГАЛЬНІ ТА ЕТИЧНІ АСПЕКТИ):		
<i>Отримати інформовану згоду на проведення обстеження</i>	Ви даєте свою згоду на проведення обстеження?	Так

Інформувати пацієнта про «лікарську таємницю»	Валентино Миколаївно, наша розмова цілком конфіденційна	Добре.
3.ЗБІР СКАРГ ТА АНАМНЕЗУ		
<i>Запитати скарги пацієнтки</i>	Валентино Миколаївно, що Вас турбує?	Напади ядухи
	Можете розповісти про характер нападів ядухи? Як часто вони виникають?	Так, звісно. Напади ядухи з утрудненим видихом. Виникали до 3 разів на тиждень, нічні напади – 2 рази на місяць.
	Що Ви приймаєте для припинення нападів?	Інгалятор «Сальбутамол»
	Вас турбує кашель?	Так
	Кашель з виділенням мокротиння чи без виділення мокротиння?	Так, з мокротинням
	Який характер мокротиння?	Невелика кількість прозорого мокротиння, дуже важко відхаркується.
<i>Запитати анамнез захворювання пацієнтки</i>	Як давно Ви хворієте?	Я хворію останні 18 років.
	До лікаря зверталися?	Так, я нахожусь на обліку у пульмонолога, він мені призначав лікування.
	Яке лікування призначав лікар-пульмонолог?	Інгалятори. Сальбутамол і формотерол/бекламетазон
	Що зараз Вас змусило звернутися до лікаря?	Останні 2 дні, у мене почастишали напади задухи в денний час до 5 на день. Ліки мені не допомагають.
<i>Запитати анамнез життя пацієнтки</i>	Чим хворіли протягом життя?	ГРВІ
	Туберкульоз, вірусні гепатити, цукровий діабет, виразкова хвороба шлунку та 12-ти палої кишки?	Ні
	Операції, травми протягом життя? Шкідливі звички?	Ні
	Алергійні реакції? Непереносимість ліків?	У мене кропив'янка на цвітіння амброзії
	Спадковість: чи хтось у сім'ї хворів хронічними захворюваннями?	Бабуся хворіє на бронхіальну астму.
ПРОДЕМОНСТРУВАТИ КОМУНІКАТИВНІ НАВИЧКИ:		

Попросити пацієнта зняти одяг	Будь ласка звільніть від одягу верхню половину тулуба, я проведу Вам порівняльну перкусію легень.	Так, зараз.
ІНШЕ (В Т.Ч. ЛЕГАЛЬНІ ТА ЕТИЧНІ АСПЕКТИ)		
Обробити руки антисептиком на гігієнічному рівні.		
4. ОБ'ЄКТИВНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ПАЦІЄНТА Додаткова інформація об'єктивного обстеження пацієнта надається здобувачу у паперовому вигляді		
Провести перкусію легень	Порівняльна перкусія легень: симетричність (визначають характер звуку в кожній точці перкусії й порівнюють його з перкуторним звуком на протилежній стороні, а також зі звуком на сусідніх ділянках легенів).	
	Порівняльна перкусія надключичних ділянок (палець-плесиметр ставиться паралельно ключиці).	
	Порівняльна перкусія легень: коректна послідовність спереду: передня поверхня грудної клітки (праворуч перкусія проводиться до зміни перкуторного звуку над усією половиною грудної клітки, а ліворуч – з урахуванням відносної серцевої тупості). Перкусія проводиться по середньоключичним лініям і вирівнюється до рівня 3 міжребер'я (далі проводиться тільки праворуч).	
	Порівняльна перкусія легень: коректна послідовність в пахвинних областях (при цьому хворій ставить руки на пояс).	
	Порівняльна перкусія легень: коректна послідовність позаду: у надлопаткових областях палець перебуває в горизонтальному положенні, у міжлопатковому просторі – у вертикальному положенні, під лопатками – знову горизонтально.	

	Оцінка перкуторного звуку над всією поверхнею легень видається в паперовому вигляді: над всією поверхнею легень визначається тимпанічний звук.	
ПРОДЕМОНСТРУВАТИ КОМУНІКАТИВНІ НАВИЧКИ:		

Уточнити самопочуття	Як Ви себе відчуваєте, все добре? Одягайтеся.	Так.
Пояснити подальші дії	Валентино Миколаївно, враховуючи, що у Вас частішали напади ядухи, раджу Вам подальше дообстеження для уточнення заключного діагнозу і корекції терапії.	
5. ВИДІЛИТИ ПРОВІДНИЙ СИНДРОМ		
	Провідний синдром – бронхообструктивний синдром.	Що робити?
6. ПРОФІЛАКТИКА ТА ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ		
	Спочатку хочу наголосити на тому, що крім регулярного прийому ліків, треба уникати провокуючих факторів, у Вашому випадку це амброзія. Обмежити використання побутової хімії, а під час прибирання користуйтеся гумовими рукавичками і маскою. Стежити за рівнем сухості повітря, за потреби – зволожувати і фільтрувати його спеціальними приладами	Дякую, лікарю
ПРОДЕМОНСТРУВАТИ КОМУНІКАТИВНІ НАВИЧКИ:		
	Валентино Миколаївно, чи Вам все зрозуміло?	Все зрозуміло
	Можливо у Вас є запитання до мене?	Немає
	Якщо Вам все зрозуміло і немає до мене більше питань, я дякую Вам за спілкування. До зустрічі.	Вам дякую лікарю, до зустрічі.